# Rapport d'analyse épidémiologique et recommandations stratégiques

## Evolution de l'épidémie à VIH en République du Congo (1990–2025)

**Groupe 8 · Akieni Academy · Formation Data Science · Évaluation : Semaine 16**

**Membres :** MALONGA MBOUITY Giversy Deliche (Lead) ; M'PIKA Emmanuelle (Dr) ; M'BIELO-LIBEAU Davis Junior ; MANDAKA MARIMPORI Edouarda ; AZIDAMA Belvine.

## I. Introduction et contexte

Ce rapport décrit l'évolution des indicateurs du VIH disponibles pour la République du Congo entre 1990 et 2025. Il vise à interpréter les résultats de l'analyse exploratoire des données (EDA), à dégager des priorités d'intervention et à préciser les limites de l'analyse.

## III. Analyse et interprétation des graphiques

### A. Prévalence du VIH

La prévalence passe de **4,82 % en 1990** à un maximum de **5,23 % en 1993**, puis diminue globalement pour atteindre **3,16 % en 2025**. Entre 1990 et 2025, le recul est d'environ **1,66 point de pourcentage**. La fin de période présente une évolution plus lente, proche de 3,2 %.

### B. Connaissance du statut sérologique

L'effectif national estimé de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut passe de **31 506 en 2015** à **53 089 en 2025**, soit une hausse d'environ **68,5 %**. Après un léger recul en 2016, la tendance progresse, avec une hausse particulièrement visible en fin de période. Cette évolution décrit un nombre de personnes diagnostiquées.

### C. Couverture des traitements antirétroviraux

La couverture ARV parmi l'ensemble des personnes vivant avec le VIH passe de **15,55 % en 2010** à **35,42 % en 2025**, soit un gain d'environ **19,87 points**. Malgré quelques fluctuations, la progression est globale et s'accentue en fin de période. L'accès au traitement s'améliore selon cette série

### D. Nouvelles infections

Les nouvelles infections annuelles estimées passent d'environ **10 346 en 1990** à un minimum de **7 099 en 2007**. Elles remontent ensuite globalement, avec des fluctuations, jusqu'à un maximum de **10 633 en 2022**. Après une baisse en 2023 et 2024, elles atteignent **10 311 en 2025**, contre 9 725 en 2024. Le niveau de 2025 est proche de celui de 1990. Cette situation soutient la nécessité de renforcer la prévention.

### E. Mortalité liée au sida

Les décès estimés passent d'environ **3 247 en 1990** à un pic de **7 699 en 2004**. La trajectoire présente ensuite une baisse, une remontée intermédiaire, puis une diminution récente. Le nombre atteint **5 607 en 2025**, soit environ **un nombre de décès moins que le pic de 2004**.

La baisse récente est encourageante, mais la mortalité reste supérieure au niveau de 1990. Une amélioration de la prise en charge peut contribuer à cette évolution.

### F. Predominance selon le sexe

Les femmes représentent environ **73 894 personnes vivant avec le VIH en 2025**, contre **26 661 hommes**, soit environ **2,77 fois** l'effectif masculin. Les deux effectifs augmentent depuis 1990, mais la hausse absolue est plus forte chez les femmes et l'écart s'élargit.

Cette observation justifie une attention particulière aux besoins des femmes, sans négliger les hommes.

### G. Répartition par groupe d'âge

En 2025, 11 **508 personnes vivant avec le VIH chez les 0–14 ans**, **19 801 chez les 15–24 ans** et **100 555 chez les 15–49 ans**. Les effectifs de fin de période sont supérieurs à ceux de 1990 pour les trois catégories.

## IV. Recommandations stratégiques

### 1. Renforcer une prévention adaptée aux besoins

La persistance des nouvelles infections appelle une prévention combinée : accès aux préservatifs, éducation à la sexualité, dépistage volontaire et confidentiel, prophylaxie pré-exposition (PrEP) selon les indications et prévention des violences. Une attention particulière doit être portée aux femmes et aux jeunes, tout en maintenant une offre accessible aux hommes. Les facteurs expliquant les disparités doivent être documentés plutôt que supposés.

### 2. Améliorer le diagnostic et l'entrée dans les soins

Diversifier les modalités de dépistage, notamment communautaires et par autotests, et faciliter l'orientation rapide vers les soins après confirmation du diagnostic. La notification aux partenaires doit respecter le consentement, la confidentialité et la sécurité. Suivre séparément le nombre de personnes connaissant leur statut et leur proportion parmi toutes les personnes vivant avec le VIH.

### 3. Étendre la couverture ARV et assurer la continuité des soins

Renforcer l'initiation du traitement et la rétention, développer la dispensation de proximité pour les patients éligibles et sécuriser l'approvisionnement. Le rapport ne mesure pas les ruptures de stocks : leur prévention est une recommandation opérationnelle, non une cause démontrée des tendances. Suivre la charge virale pour documenter les résultats thérapeutiques. Le principe « Indétectable = Intransmissible » concerne la transmission sexuelle du VIH lorsque la charge virale est durablement indétectable.

### 4. Adapter les services aux enfants et aux jeunes

Renforcer la prévention de la transmission mère-enfant, le diagnostic précoce, les traitements pédiatriques et l'accompagnement des familles. Pour les jeunes, proposer un accueil confidentiel et sans jugement, des horaires adaptés et une transition organisée vers les services adultes. Ces orientations ne reposent pas sur une mesure spécifique des adolescents de 10–19 ans, absente du découpage disponible.

### 5. Améliorer le suivi des indicateurs

Documenter le numérateur, le dénominateur, la source, l'unité et la population de chaque indicateur. Suivre distinctement les trois objectifs 95 : connaissance du statut parmi les PVVIH ; traitement parmi les personnes connaissant leur statut ; suppression virale parmi les personnes traitées. Compléter le suivi par la rétention, les ruptures de stocks et une ventilation par sexe, âge et territoire lorsque les données deviennent disponibles.

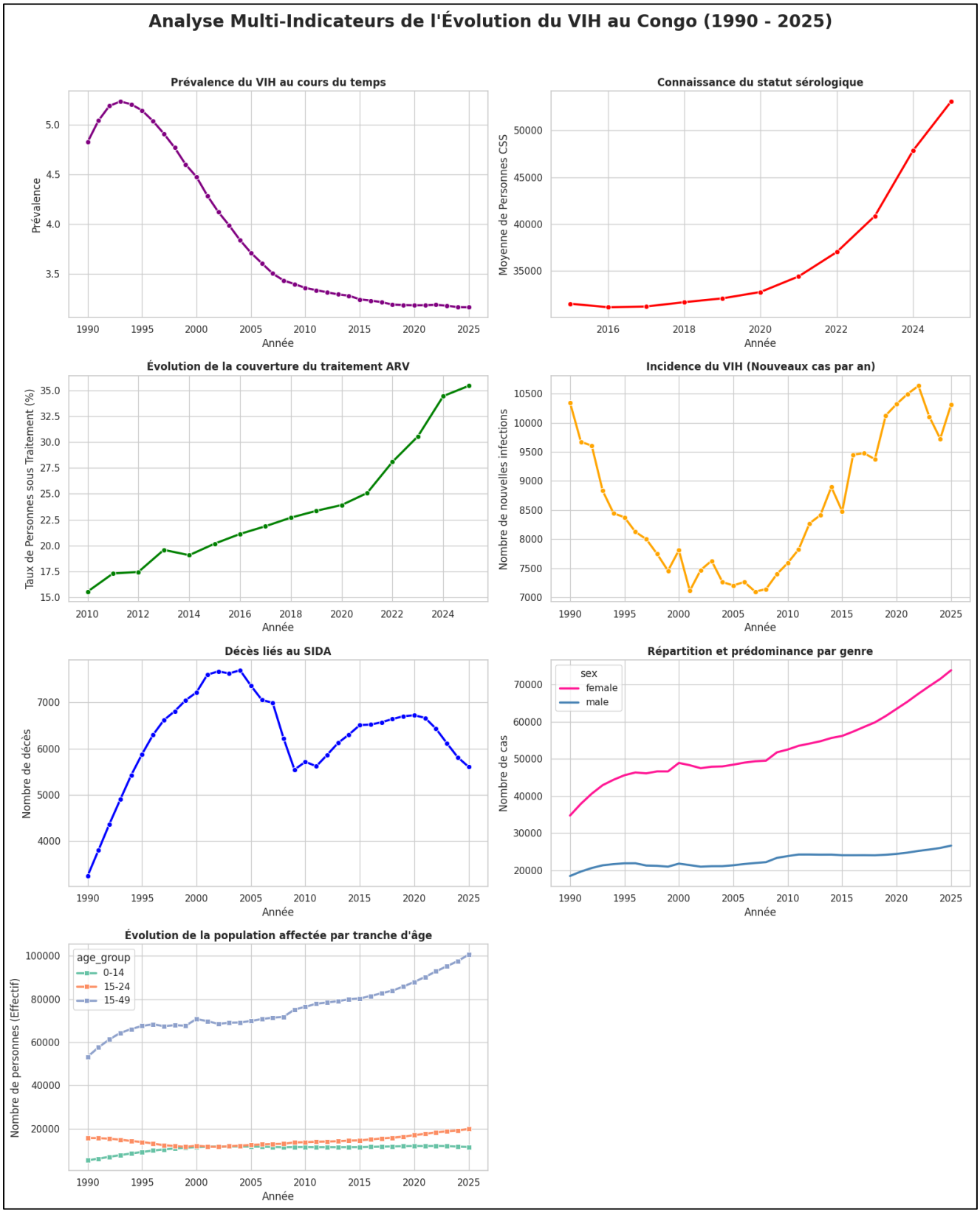
## V. Limites de l'analyse

- **Suppression virale indisponible :** aucun indicateur explicite ne permet de calculer le troisième 95. L'efficacité virologique des traitements ne peut donc pas être évaluée ; absence de données ne signifie pas absence de suppression virale.
- **Découpage par âge :** les 0–14, 15–24 et 15–49 ans ne permettent pas d'isoler les 10–19 ans. Les deux dernières catégories se chevauchent et les 50 ans et plus ne sont pas représentés séparément dans le graphique.
  **Incertitude et causalité :** Les variations récentes doivent être interprétées avec prudence. Une EDA descriptive ne démontre ni les causes des disparités ni l'impact causal d'une politique ou d'un traitement.

## VI. Conclusion

La série d'études présente une baisse globale de la prévalence depuis le début des années 1990, une progression du diagnostic en effectif et de la couverture ARV, mais aussi la persistance d'un nombre élevé de nouvelles infections. La mortalité récente recule sans effacer le fardeau de l'épidémie. La prédominance selon le genre est plus fort du coté des femmes. Les priorités sont une prévention adaptée, un accès élargi et continu aux soins et une amélioration de la qualité des données.

# VII. Annexes


Analyse Multi-Indicateurs de l'Évolution du VIH au Congo (1990 - 2025)
Prévalence du VIH au cours du temps
Prévalence
Année
Connaissance du statut sérologique
Moyenne de Personnes CSS
Année
Évolution de la couverture du traitement ARV
Taux de Personnes sous Traitement (%)
Année
Incidence du VIH (Nouveaux cas par an)
Nombre de nouvelles infections
Année
Décès liés au SIDA
Nombre de décès
Année
Répartition et prédominance par genre
sex
female
male
Nombre de cas
Année
Évolution de la population affectée par tranche d'âge
age_group
0-14
15-24
15-49
Nombre de personnes (Effectif)
Année